

COMUNICACIÓ DADES

- EDAT I SEXE
- PRIORITAT
 0. Té algun criteri fisiològic
 1. Té algun criteri anatòmic
 2. Té criteris de mecanisme lesional de risc
 3. Té algun antecedent patològic rellevant
- ALFA: Tipus d'accident
 0. Desconegut
 1. Accident de trànsit
 2. Atropellament (inclou vianant i ciclista)
 3. Precipitat/caiguda
 4. Agressió per arma blanca o de foc
 5. Agressió per altres mecanismes
 6. Cremat
 7. Ofegat (aigua dolça, salada o altres)
 8. Accident al Metro o Ferroviari
 9. Altres
- CHARLIE: Zona del cos
 0. Sense lesions aparents
 1. Cap
 2. Cara
 3. Coll
 4. Tòrax
 5. Abdomen
 6. Pelvis (òssia)
 7. Raquis (columna vertebral)
 8. Extremitats (superiors/inferiors)
 9. Lesions externes (inclou cremades)
- ROMEO: Respiració
 0. Maneig invasiu de via aèria (IOT, mascareta laringea, cricotirotomia,...)
 1. Dificultat respiratòria
 2. Normal
- HOTEL: Estat hemodinàmic

ADULTS	NENS
0. Sense pols	0. PC (no) PP (no)
1. TAS 50-90 mmHg	1. PC (sí) PP (no)
2. TAS >90 mmHg	2. PC (sí) PP (sí) mala perfusió
	3. PC (sí) PP (sí) bona perfusió
- GOLF: Nivell de consciència inicial (en la 1a valoració del malalt)

GCS, xifra global
- HORA D'ARRIBADA PREVISTA

Hora i minut

Per relacionar les dades entre el SEM i els hospitals receptors, cal facilitar el número d'afectat i, si és possible, el CIP.

ESCALES DE VALORACIÓ

GLASGOW Adult

Lleu: 14-15, Moderat: 9-13, Greu <8

Millor obertura ocular		Millor resposta verbal		Millor resposta motora	
Espontània	4	Orientat	5	Compleix ordres	6
A l'estímul verbal	3	Confús	4	Localitza estímul dolorós	5
A l'estímul dolorós	2	Paraules inapropiades	3	Retira a estímul dolorós	4
No respon	1	Sons incomprensibles	2	Resposta flexió (decortiació)	3
		No respon	1	Resposta extensió (decortiació)	2
				No respon	1

GLASGOW Pediàtric

Lleu: 14-15, Moderat: 9-13, Greu <8

Millor obertura ocular		Millor resposta verbal		Millor resposta motora	
Espontània	4	Balboteig	5	Moviments espontanis	6
A l'estímul verbal	3	Irritable	4	Retira al tocar	5
A l'estímul dolorós	2	Plora al dolor	3	Retira al dolor	4
No respon	1	Gemecs al dolor	2	Flexió anormal	3
		No respon	1	Extensió anormal	2
				No respon	1

TRAUMATOLOGIA. Revised Trauma Score (RTS)

Adult

RTS<12 requereix trasllat a centre de trauma especialitzat

Freq.respiratòria.rpm		Tensió arterial Sistòlica		Escala Glasgow	
10-29	4	>89	4	13-15	4
> 29	3	76-89	3	9-12	3
6-9	2	50-75	2	6-8	2
1-5	1	1-49	1	4-5	1
0	0	0	0	3	0

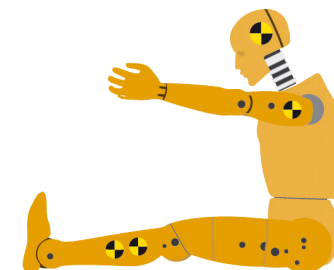
TRAUMATOLOGIA. Índex Trauma Pediàtric (ITP)

Pediàtric

ITP<8 requereix trasllat a centre de trauma especialitzat

	+2	+1	-1
Pes (kg)	> 20	10-20	<10
Via aèria	Normal	Sostenible	Insostenible
Tensió arterial sistòlica (TAS) mmHg	> 90	50-90	<50
Nivell de consciència	Conscient	Obnubilat	Coma
Ferides	No	Menor	Major o penetrant
Fractures	No	Tancada	Oberta o múltiples

codi PPT



Atenció
d'emergència al
malalt
traumàtic



Autors: GdTde Trauma de la Junta Clínica SEM. Revisió Desembre 2017.

canalsalut.gencat.cat



emergències mèdiques



CRITERIS D'IMMOBILITZACIÓ

112
emergències

ACTIVACIÓ
CODI PPT
Prioritat 3

- Embarassada en estat avançat de gestació (>20 setmanes)
- Anticoagulació o alteració de la coagulació
- Pacient en tractament amb diàlisi i/o múltiples patologies
- Nens petits i persones d'edat avançada (orientatiu <3 i >65 anys)
- Criteri del professional

1	Llitera de l'hospital amb tauler espinal + immobilitzador pèlvic (si està indicat).
2	Posicionar lliteres prehospitalària i hospitalària juntes, a la mateixa alçada.
3	Transferir el malalt des de la llitera SEM a la de l'hospital amb el matalàs de buit, amb el buit fet. Si es precisa tornar a fer el buit, utilitzar l'aspirador de l'hospital.
4	Retirar el matalàs de buit amb la tècnica del pont lateral (assistencials a cada costat del malalt i líder a la capçalera).
5	Mantenir en tot moment la visió del malalt: monitoratge, control de tubs, sondes i altres dispositius.
6	Intercanvi i recuperació de material. A ser possible sense treure el del malalt.

Individualitzar destí si inestabilitat hemodinàmica.